Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/6	
Título do Documento	**PREVENÇÃO DE QUEDAS**	Emissão: 01/08/2026 Versão: 2	Próxima revisão: 01/08/2028

1. CONCEITO: Trata dos procedimentos operacionais para garantir a prevenção de quedas em indivíduos internados no HSVP

1.1 Responsável pela prescrição
Enfermeiro

1.2 Responsáveis pela execução
É de responsabilidade de todos os profissionais da assistencia (Equipe Multidisciplinar)

1.3 Finalidades

- Reduzir a ocorrência de queda de clientes nos pontos de assistência e os danos dela decorrentes, por meio da implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco do cliente, garantam o cuidadomultiprofissional em um ambiente seguro, e promovam a educação do cliente, familiares e profissionais;
- Nortear o atendimento imediato pós queda;
- Fornecer indicadores para estratégias de segurança e melhoria da assistência à saúde;
  Proporcionar atendimento assistencial efetivo, sistematizado, seguro e qualificado aos clientes efamiliares.

1.5 Contraindicações/Restrições
Não há

2. MATERIAIS

- Computador
- Prontuário eletrônico
- Escore de Morse (estratificação do risco de queda)

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Equipe multidisciplinar

- Avaliar o risco de queda pela escala de MORSE; o Inserir o risco de queda na ficha de identificação do cliente;
- Assegurar que as camas permaneçam em posição mais baixa, com as rodas travadas e as grades elevadas no momento de repouso.
- Avaliar a independência e a autonomia para deambulação e a necessidade de utilização de dispositivo de marcha do cliente (por exemplo, andador, muleta e bengala);
- Atenção aos calçados utilizados pelos clientes;
- Orientar o cliente a levantar devagar, sentar no leito e apoiar os pés sobre a escada ou no chão, para depois sair da cama (essa orientação também deve ser dada ao acompanhante);
- Oferecer suporte de soro com rodas;
- Comunicar qualquer não conformidade ao enfermeiro.
- Orientar quanto ao dispositivo/equipamento e a sua necessidade de uso;
- Avaliar o nível de dependência e autonomia após a instalação de equipamentos, para planejamento da assistência relacionado à mobilização deste cliente;
- Alocar os equipamentos/dispositivos de maneira a facilitar a movimentação do cliente no leito ou a sua saída;
- Orientar o cliente e acompanhante para garantir a utilização de seus óculos e/ou aparelho auditivo sempre que for sair da cama;
- Dispor a campainha ao alcance do cliente e orientá-lo como utilizá-la;
- Checar o bom funcionamento/integridade da maca, cadeira de rodas ou do outro meio de locomoção, antes de transportar o cliente;
- Solicitar avaliação médica para contenção química, quando o cliente possuir risco de queda ou de outra lesão, devido a agitação psicomotora, mesmo com a contenção mecânica;
- As contenções mecânica e química poderão ser indicadas ao cliente com alto risco para queda, e deverão ser prescritas pelo médico;
- Realizar avaliação da força muscular, sensibilidade e marcha do cliente com dificuldade de locomoção, programando e realizando o tratamento específico para melhora do quadro;
- Qualquer não conformidade registrar em prontuário.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

Serviço de Limpeza:

- Utilizar as placas de identificação alertando para "Piso Molhado" ao realizar a limpeza dos quartos, banheiros, corredores e ao identificar vazamentos.

Clientes com necessidades fisiológicas e higiene pessoal que necessitam de auxílio:

- Permanecer ao lado do cliente cirúrgico durante todo o momento de indução e reversão anestésica;
- Manter as grades da cama elevadas durante a recuperação do processo anestesiológico;
- Orientar os clientes no 1º pós-operatório a aguardarem ser encaminhados ao banho de aspersão pela equipe de enfermagem quando se tratar da primeira vez que se levantam;
- Orientar cliente e acompanhante para somente levantar do leito acompanhado por profissional da equipe de cuidado, mesmo na presença de acompanhante para clientes com alto risco para queda.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

Escore de Morse

Perguntas	Respostas
HISTORICO DE QUEDA	NAO
DIAGNOSTICO SECUNDARIO	SIM
AUXILIO NA DEAMBULAÇÃO	NENHUM/AUXILIADO POR PROFISSIONAL DE SAUDE/ACAMADO
TERAPIA I.V/DISPOSITIVO I.V SALINISADO OU I	SIM
MARCHA	NORMAL\SEM DEAMBULAÇÃO,ACAMADO,CADEIRA DE RODAS
ESTADO MENTAL	ORIENTADO/CAPAZ QUANTO A SUA CAPACIDADE/LIMITACAO
RESULTADO	35
INTERPRETAÇÃO	RISCO MODERADO
INTERVENÇÃO	RISCO MODERADO



6. REFERÊNCIAS

MINISTERIO DA SAÚDE. Anexo 01: PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS. Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz;2013. Disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle infeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_prevencao.pdf. Acesso em: 05 de junho de 2023.

Garcia, S. M., Aristela, C., Grassi, L. T., de Araujo, C. C., Hartwig, S. V., & Valadares, T. A. B. (2020). Educação em saúde na prevenção de quedas em idosos. *Brazilian Journal of Development*, *6*(7), 48973-48981.Disponivel em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13589.

Bonardi, T., Silva, L. G., Santos, D. C. D., Antonio, J. C., & Soler, V. M. (2019). Morse Fall scale: grau de risco de queda em idosos hospitalizados. *CuidArte, Enferm*, 147-151. Disponivel em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1087628

7. HISTORICO DE ELABORAÇAO/REVISAO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
1	01/08/2023	Atualização e padronização
2	01/07/2025	Atualização
3	01/08/2026	Atualização

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2025
Revisão Giulianna Carla **Validação** Claudio Emmanuel **Registro, análise e revisão final** Giulianna Carla Claudio Emmanuel **Aprovação** Claudio Emmanuel Sonia Delgado	Data: 01/08/2026